EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 87350
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-26 11:02:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: INES DEL ROSARIO NAVARRETE ARAYA			RUN	: 6.785.741-0
F.Nac	: 30-05-2023	Edad	: 1 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-24	Fecha Egreso	: 2024-06-26 11:02:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia Respiratoria Aguda:
-Neumonía bilateral
AKI KDIGO I
CA recto en CP
Trastorno depresivo leve
Obs Demencia
AP: DMT2, HTA, DHC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos cuyo familiares refiere inicio de sintomatología hace al menos 2-3 días, presentando compromiso del estado general, cambio de color en la orina (desde ayer oligurica), asociado a dolor abdominal.
Ingresa a urgencias con compromiso ventilatorio, desaturando, por lo que amerita apoyo con oxígeno.
Asociado a ello, mayor compromiso de consciencia, somnolienta, desorientada.
En vista de condiciones se decide ingreso

Ex lab ingreso:
hb 12.4/ leucocitos 9600/ plaquetas 152000
inr 1.23/bun 28/ uremia 60/ sodio 140/ potasio 3.8/ cloro 103/glicemia 206*/ crea 1.5/ urico 4./ calcio 8.1*/ fa94/ bi 0.78/ bd 0.32/ bt 1.1/got 26/ gpt 16/ ggt 15/ pcr 232/orina no se observan bacterias/ influenza negativo/ covid negativo / vrs negativo

Se valora TC de TX que impresiona compromiso pulmonar bilateral de caracter infeccioso-inflamatorio con predominio en campo pulmonar izquierdo.

Hospitalización reciente en contexto de ITU con egreso hospitalario para el 17/06.

Ex físico
Piel: cambios y signos propios de la edad. Llenado capilar límite.
CP: Torax asimétrico, hipoexpansible, WOB+, RSRSPS, estertores bilaterales preodmino izq, Crépitos+ izquierdo, RSCSRSRS
Abd: RHA+, Leve dolor a la palpación predominio hemiabdomen inferior.
Neurológico: Somnolienta, orientada en persona y espacio, desorientada en tiempo. Sin signos de focalización

o irritación meníngea.

Durante estancia en servicio en medicina recibiendo terapia ATB con Ceftriaxona. Parámetros inflamatorios en descenso, con disminución de requerimiento de oxígeno. Para momento de valoración, con mas de 24 horas en ausencia de soporte O2. En vista de condiciones, se decide continuidad de atención por HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. Ceftriaxona 2gr ev día
2. Omeprazol 20mg vo día
3. Clonazepam 2mg vo día
4. Losartan 50mg vo c12h (PAM >70mmHg)
5. Paracetamol 1gr vo c8h
6. Durogesic 50mg parche cada 72h
7. Bromuro ipratropio 4puff c8h
8. Brexotide 2 puff c12h
9. Paracetamol 1gr vo c8h SOS
10. Haldol 1 mg vo noche
11. Control SU SOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO